

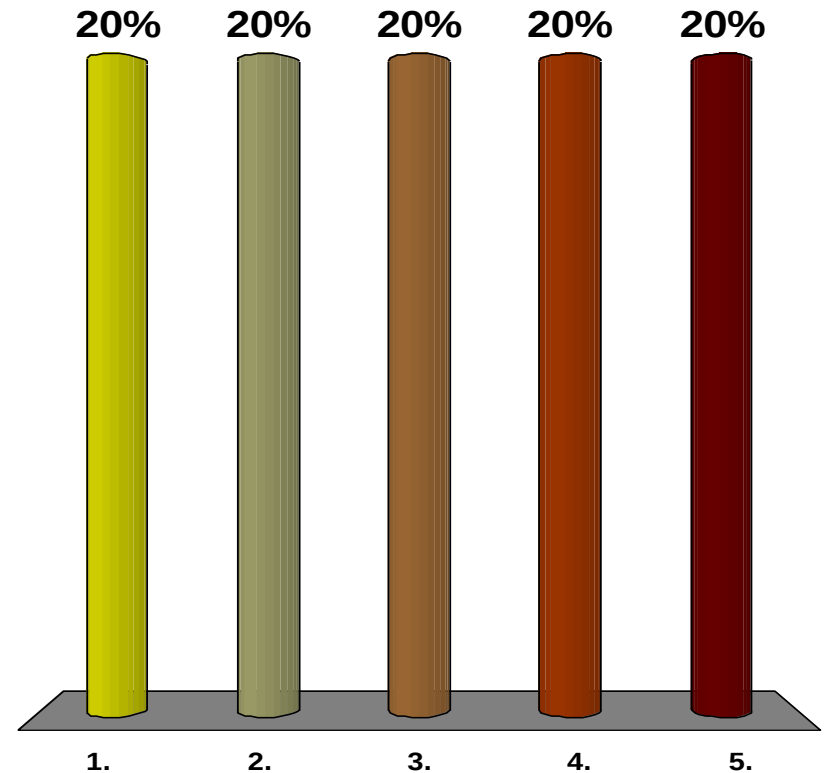
Un patient de 75 ans se plaint d'une diminution soudaine de la vue de l'œil gauche. L'examen du fond d'œil montre une papille gauche pâle et turgescente. Il signale également une diminution de l'appétit, une perte de pondérale de 3kg. Lors de la mastication il ressent une douleur mandibulaire. Quel examen de choix effectuez-vous ?



1. Un scanner cérébral
2. Une VS et une CRP
3. Une biopsie de moelle osseuse
4. Une colonosocopie
5. Un examen cutané à la recherche d'un carcinome basocellulaire

Quel examen demandez-vous ?

1. Scanner cérébral
2. VS et CRP
3. Biopsie de moelle osseuse
4. Colonoscopie
5. Examen dermatologique (recherche carcinome basocellulaire)



VS et CRP

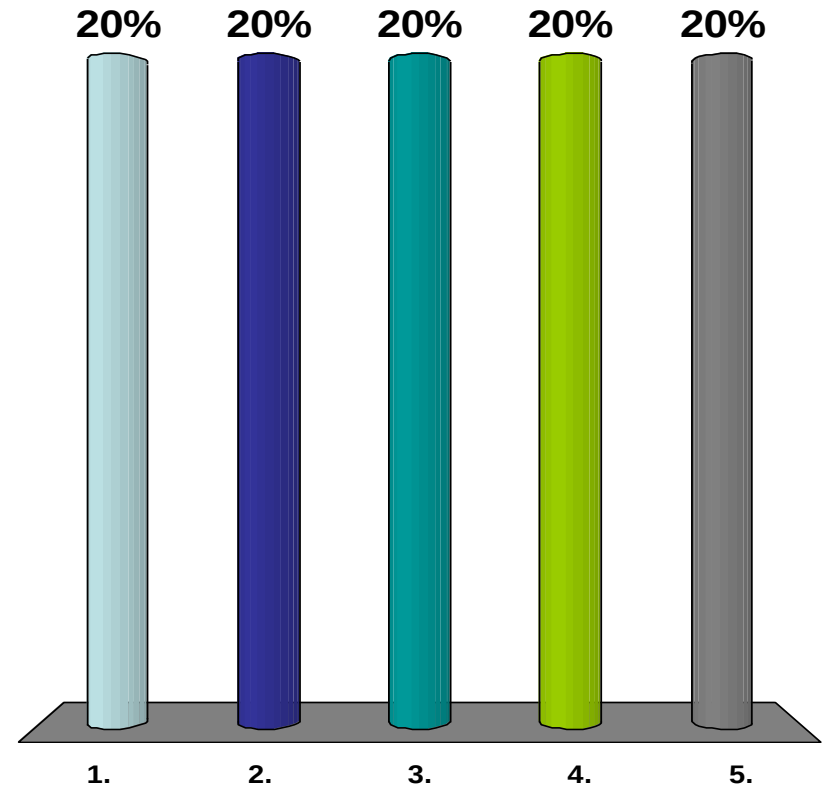
Artérite gigantocellulaire ou maladie de Horton Urgence Ophtalmologique

- Touche patients > 50 ans, max. entre 75-80 ans
- **Symptômes oculaires:** Baisse de vue unilatérale ou bilat, indolore; cécité dans 10% des cas. Diplopie.
- **Symptômes systémiques:** toutes les artères peuvent être touchées. Douleurs articulaires, atteinte des poumons, manifestations neurologiques, psychiatriques etc...
- Angiographie fluorescéinique utile, retard de remplissage, ischémie de la choroïde
- **Diagnostic** biopsie de l'artère temporale.
- **Traitement :** corticostéroïdes à forte dose
(bolus solumedrol puis relais oral)

- Patient 65 ans, sans antécédent ophtalmologique,
- baisse d'acuité visuelle, blouissement. Acuité visuelle est de 1/10^{ème} à chaque œil sans correction, mais remonte à 3/10^{ème} à chaque œil après correction d'une myopie bilatérale de -2 dioptries.
- Le patient n'avait jamais eu de correction optique auparavant et cette myopie est nouvelle.
- A l'anamnèse, le patient signale des traitements multiples par voie générale:
 - corticothérapie au long cours pour un rhumatisme inflammatoire,
 - aspirine
 - antihypertenseurs
 - antidépresseurs tricycliques
 - statines

Quel est le traitement pris par voie générale susceptible d'expliquer sa pathologie ?

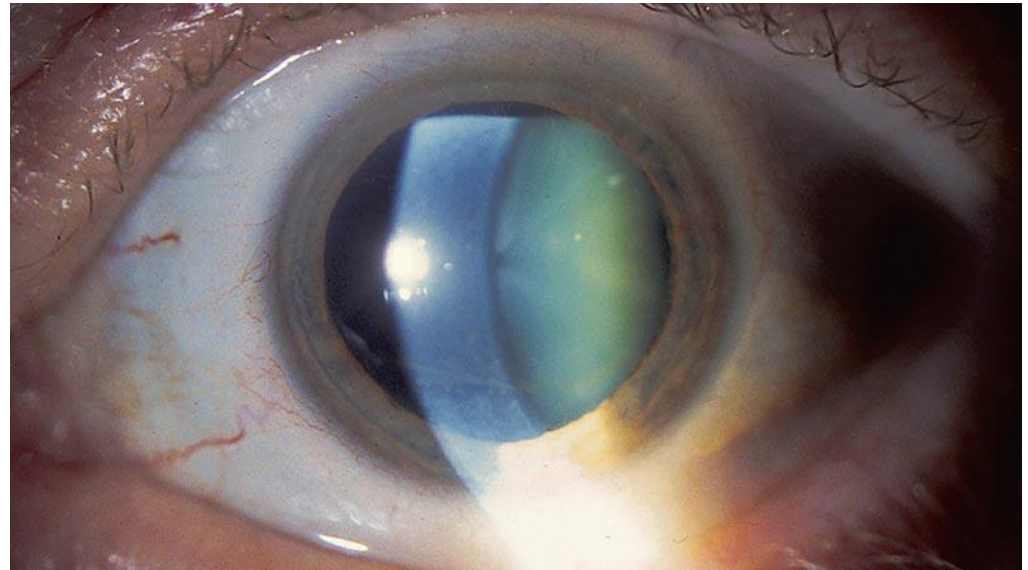
1. Corticothérapie au long cours
2. Aspirine
3. Antihypertenseur
4. Antidépresseurs tricycliques
5. Statines



Cataracte

Corticothérapie au long cours pour un rhumatisme inflammatoire

- La sclérose nucléaire provoque une myopisation d'indice de réfraction : le patient voit mieux de près qu'avant.
- Etiologies de la cataracte:
 - Sénile
 - Maladie systémique:
 - Diabète
 - Hypocalcémie
 - Mal Steinert
 - Mal Wilson
 - Trauma
 - Médicamenteuse:
 - **Corticoïdes**
 - phénothiazines
 - myotiques



Une femme de 65 ans souffre d'une baisse d'acuité visuelle dans son œil droit, sans douleur, progressive depuis 3 mois, associée à des métamorphopsies. L'examen de la macula droite révèle des hémorragies, des exsudats lipidiques et quelques drusen séreuses.

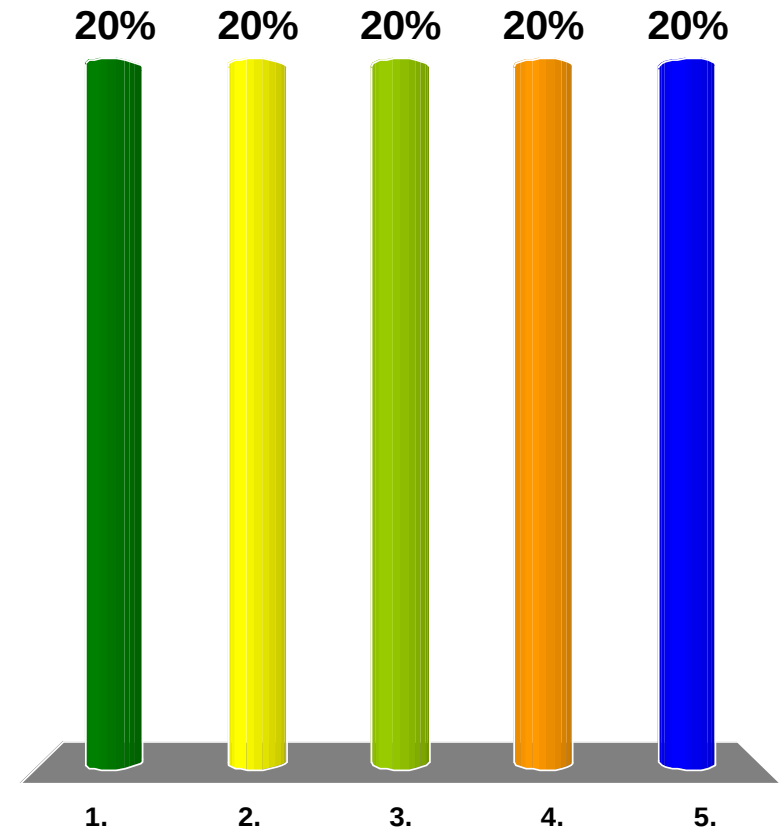
La prise en charge la plus adéquate est la suivante :



- 1) Traitement des facteurs hématologiques pathologiques
- 2) Traitement anti-VEGF intraoculaire
- 3) Traitement au laser
- 4) Aucun traitement disponible
- 5) Conseil génétique et mettre sur liste d'attente pour traitement génétique à l'avenir

La prise en charge la plus adéquate de la pathologie décrite est la suivante

1. Traitement des facteurs hématologiques pathologiques
2. Traitement anti-VEGF intraoculaire
3. Traitement au laser
4. Aucun traitement disponible
5. Conseil génétique et mettre sur liste d'attente pour traitement génétique à l'avenir



Dégénérescence maculaire liée à l'âge

Traitement anti-VEGF intraoculaire

- Age >55ans
- Facteurs de risque: age, génétique, nicotine

- **Forme précoce:** drusen, remaniements de l'épithélium pigmentaire, peu d'effet sur vision
Vitaminothérapie antioxydative

- **Forme avancée atrophique:** atrophie avec perte fonctionnelle selon emplacement par rapport à la fovéa, lentement progressive
Pas de traitement disponible

- **Forme avancée néovasculaire:** membrane néovasculaire choroïdienne = sousrétinienne, exsudation séreuse, hémorragies, perte fonctionnelle centrale rapidement progressive
Traitement:
 - 1er choix: anti-VEGF intravitréen
 - 2ème choix: thérapie photodynamique
 - Éventuellement photocoagulation au laser

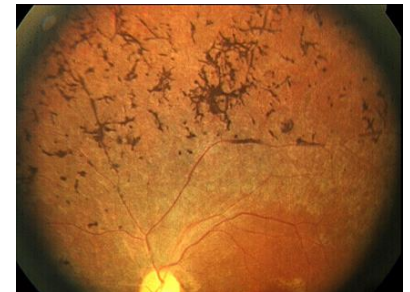
- Diagnostic: fond d'œil, angiographie (hyperfluorescence avec diffusion en cas de néovaisseaux choroïdiens)



■ Un homme de 27 ans, se plaint de souvent ne pas remarquer les obstacles par terre. Il doit scanner son environnement pour ne pas se heurter à un objet. Au cinéma, il ne trouve pas son siège à l'obscurité. Il ne sort plus le soir de peur de ne pas trouver son chemin. Cependant, il n'a aucun problème de lecture.

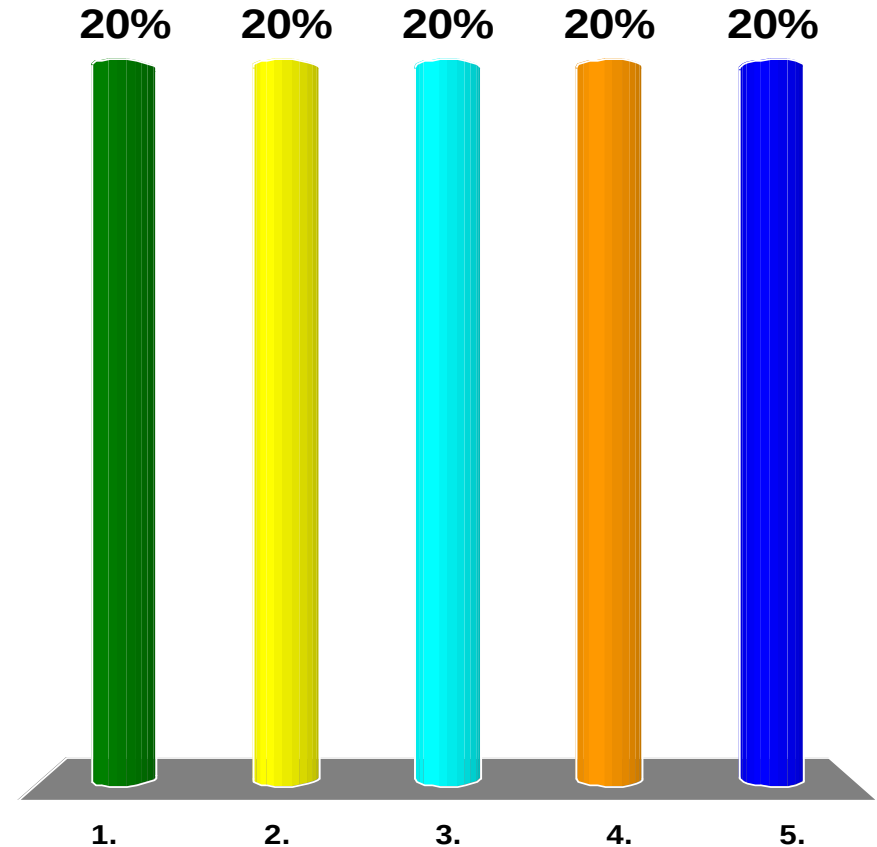
Ces symptômes sont compatibles avec quelle fonction visuelle ?

1. Acuité visuelle 10/10 et champ visuel 140°
2. Acuité visuelle 1/10 et champ visuel 180°
3. Acuité visuelle 1/10 et champ visuel 10°
4. Acuité visuelle 10/10 et champ visuel 20°
5. Acuité visuelle 1/10 et champ visuel 20°



Ces symptômes sont compatibles avec quelle fonction visuelle ?

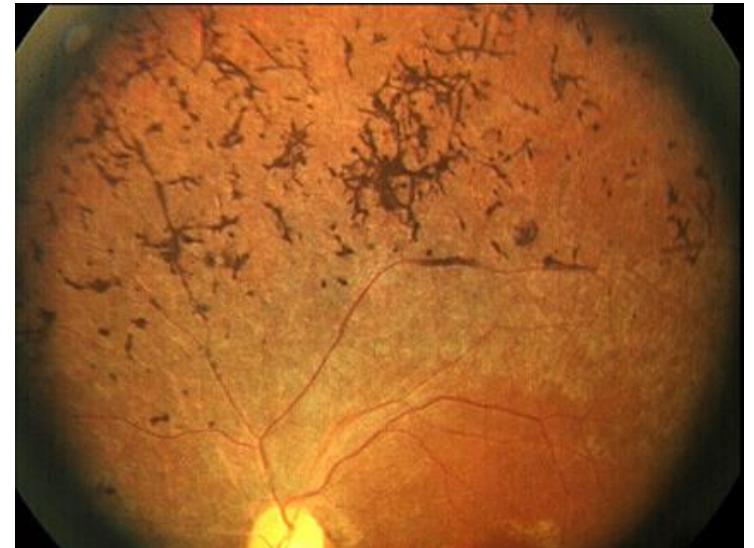
1. AV 10/10 et CV 140°
2. AV 1/10 et CV 180°
3. AV 1/10 et CV 10°
4. AV 10/10 et CV 20°
5. AV 1/10 et CV 20°



Rétinite pigmentaire

Acuité visuelle 10/10 et champ visuel 20°

- Dystrophie bâtonnets-cônes
→ examen: ERG
- Héritaire
multitude de gènes impliqués
 - Transmission récessive
 - Transmission dominante
 - Transmission liée au sexe
- Symptômes:
 - Cécité nocturne, plus tard rétrécissement du champ de vision, finalement perte de vision centrale
- Présentation typique:
 - Spicules pigmentaires en périphérie
 - Atrophie périphérique
 - Rétrécissement des artères rétiniennes
 - Finalement pâleur de la papille (légère cataracte, légère inflammation)



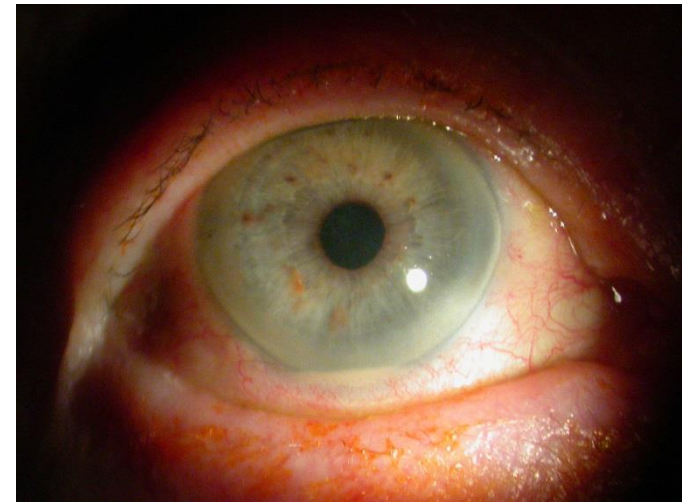
Prise en charge:

- Pas de traitement spécifique
- Conseil génétique
- Aide par appareillage adéquat, soutien AI

Un patient de 82 ans est opéré de la cataracte de l'œil droit il y a une semaine. Depuis ce matin, il ressent une douleur sourde à l'œil droit lorsqu'il passe le seuil de sa porte. Il remarque également que la vision de son œil opéré est moins nette depuis 24 heures.

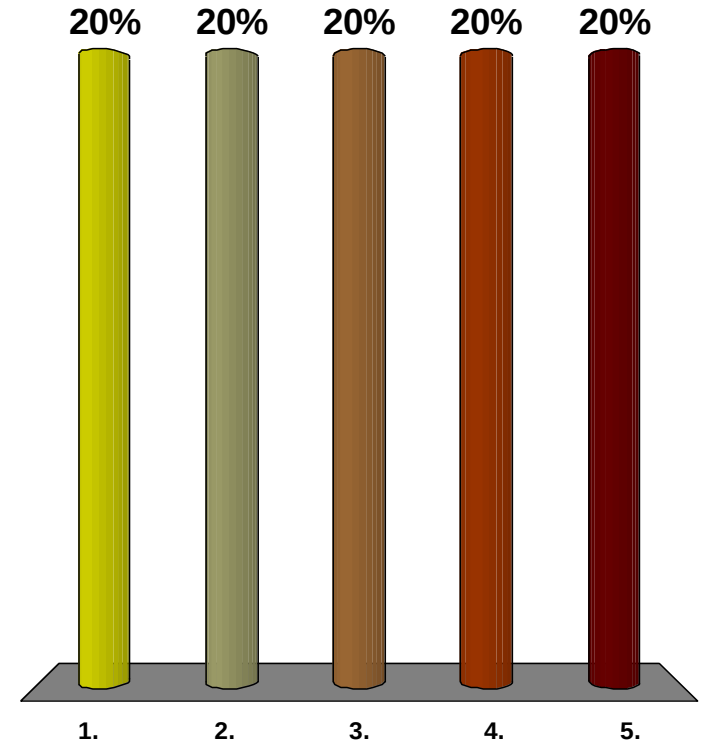
Quelle pathologie faut-il suspecter ?

1. Décollement de rétine
2. Glaucome chronique à angle ouvert
3. Hémorragie vitréenne
4. Endophtalmie bactérienne
5. Occlusion de la veine centrale de la rétine



Quelle pathologie faut-il suspecter ?

1. Décollement de rétine
2. Glaucome chronique à angle ouvert
3. Hémorragie vitréenne
4. Endophtalmie bactérienne
5. Occlusion de la veine centrale de la rétine



Endophtalmie bactérienne

Définition:

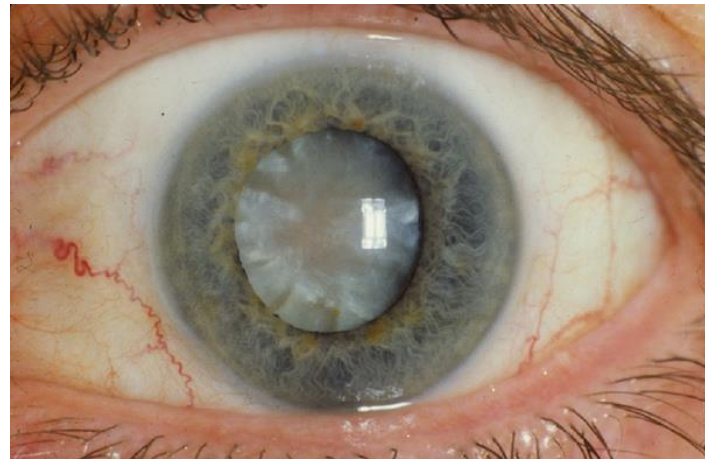
infection intraoculaire (origine postopératoire ou endogène)

Germes: germes de la peau avant tout (principalement staphylocoques etc....)

Signes et Symptômes : douleur, photophobie, diminution de vue fréquente, rougeur oculaire, parfois oedème palpébral, hypopion, vitrite.

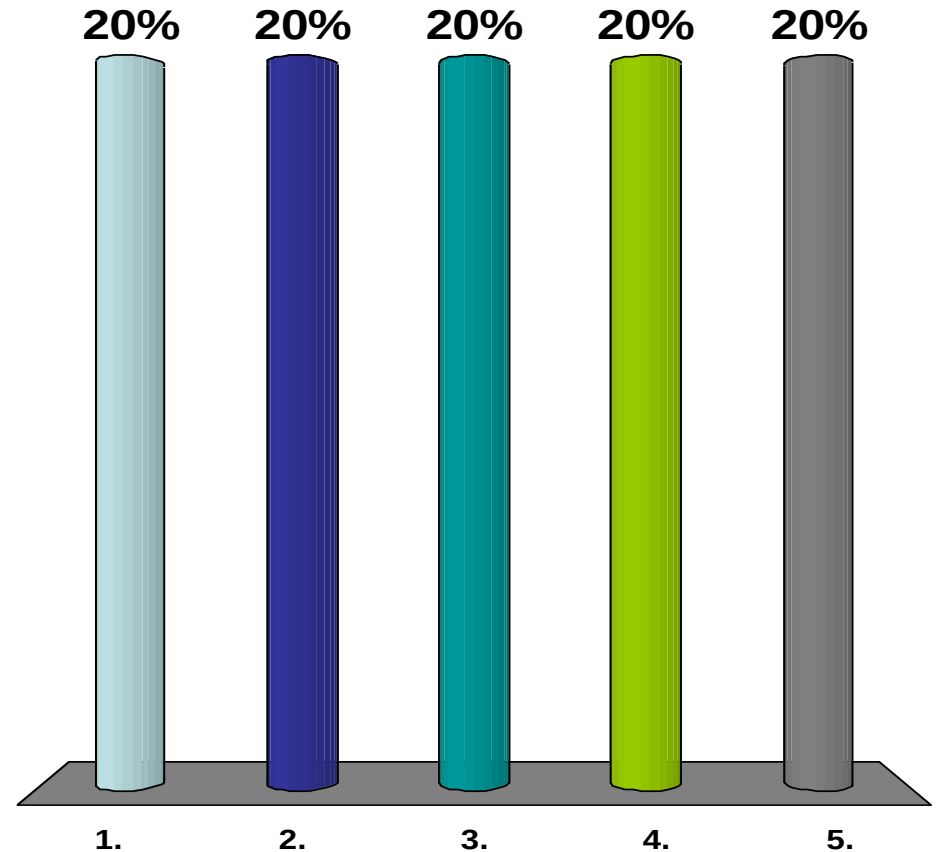
Traitement : Urgence ophtalmologique nécessite une hospitalisation pour vitrectomie diagnostique (germe) et traitement.

- Un homme de 40 ans présente une baisse progressive d'acuité visuelle. Il n'a aucun autre antécédent pathologique connu. Il se plaint de difficultés visuelles lors de la conduite automobile, pour regarder la télévision et pour marcher dans la rue. Il consulte un ophtalmologiste qui diagnostique une cataracte bilatérale, prédominante à droite. L'acuité visuelle est de 5/10^{ème} du côté droit, de 6/10^{ème} du côté gauche.
- Quel est l'examen le plus approprié pour diagnostiquer l'étiologie de la cataracte ?
 1. Electrorétinogramme
 2. Bilan orthoptique
 3. Echographie
 4. Glycémie
 5. Champ visuel



Quel est l'examen le plus approprié pour diagnostiquer l'étiologie de la cataracte ?

1. Electrorétinogramme
2. Bilan orthoptique
3. Echographie
4. Glycémie
5. Champ visuel



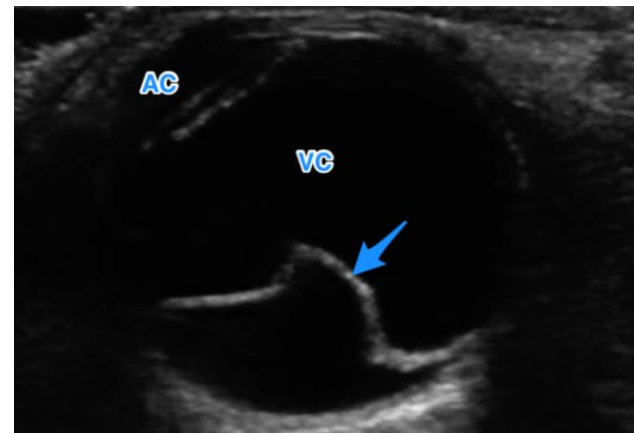
Cataracte

Glycémie

- La cataracte sénile ne survient pas en principe à l'âge de 40 ans mais dès 60ans.
- Cette précocité impose de rechercher une autre étiologie.
- L'**hyperglycémie** peut changer la puissance réfractive du cristallin (myopisation) et engendrer une symptomatologie avec baisse d'acuité visuelle.
- La myopisation avec « baisse de vision » peut être l'un des premiers symptômes d'un diabète.

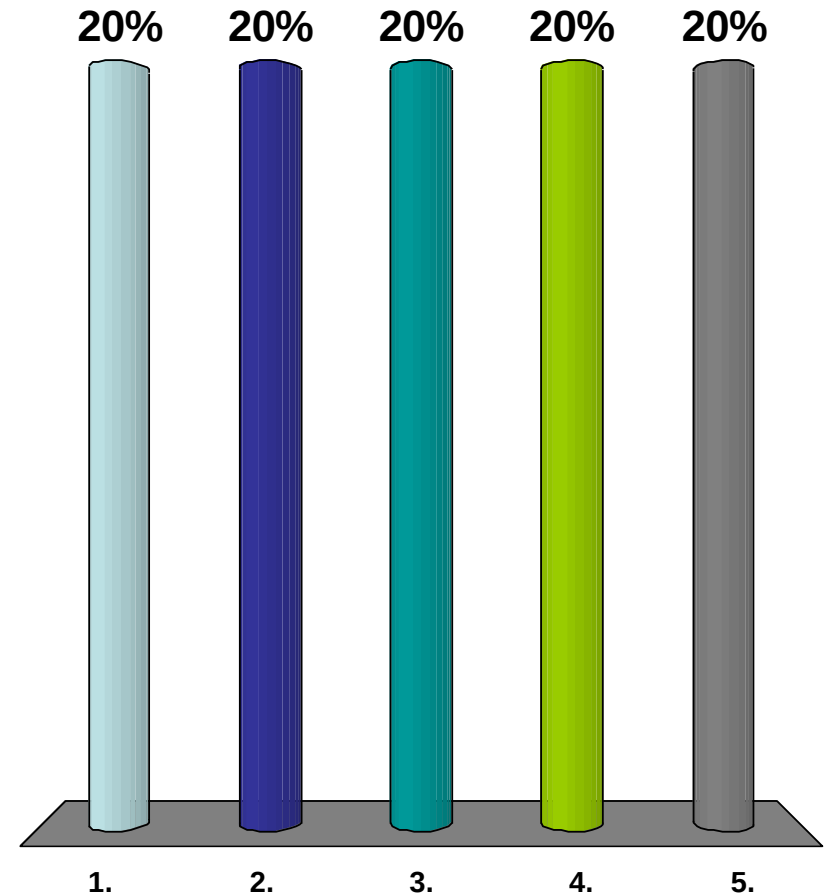
- Une femme de 70 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer présente une baisse de vision de l'hémichamp visuel inférieur de l'œil gauche, apparue 4 jours après son opération de la cataracte.
- L'opération s'était très bien déroulée.
- Avant l'opération, la patiente portait une correction de -16D à l'œil droit et de -19 à l'œil gauche.
- L'examen ophtalmologique de la patiente est très difficile en raison de son manque de collaboration.
- Quel examen diagnostique est le plus approprié chez cette patiente ?

1. Electrorétinogramme
2. Bilan orthoptique
3. Echographie
4. Glycémie
5. Potentiels évoqués visuels



Quel examen diagnostique est le plus approprié chez cette patiente ?

1. Electrorétinogramme
2. Bilan orthoptique
3. Echographie
4. Glycémie
5. Potentiels évoqués visuels



Décollement de rétine

Echographie

- Le décollement de rétine est une des complications de la chirurgie de la cataracte, plus fréquente chez les myopes forts.
- Le décollement peut survenir même sans complications peropératoires. Les mouvements de la chambre antérieure et les tractions vitréennes induites inhérents à la chirurgie sont la cause du décollement, d'autant plus sur une rétine fine et fragile du myope fort.
- Le décollement de rétine se manifeste par une baisse de vision dans le quadrant correspondant du champ visuel.
- L'examen du fond d'œil peut poser le diagnostic ou l'échographie qui objective la rétine décollée.

Un écolier de 14 ans présente une importante rougeur de son œil droit, une adénopathie prétragiale est palpée. Un écoulement séreux abondant est présent. Il a également présenté quelques jours auparavant une angine.

Le diagnostique le plus probable:

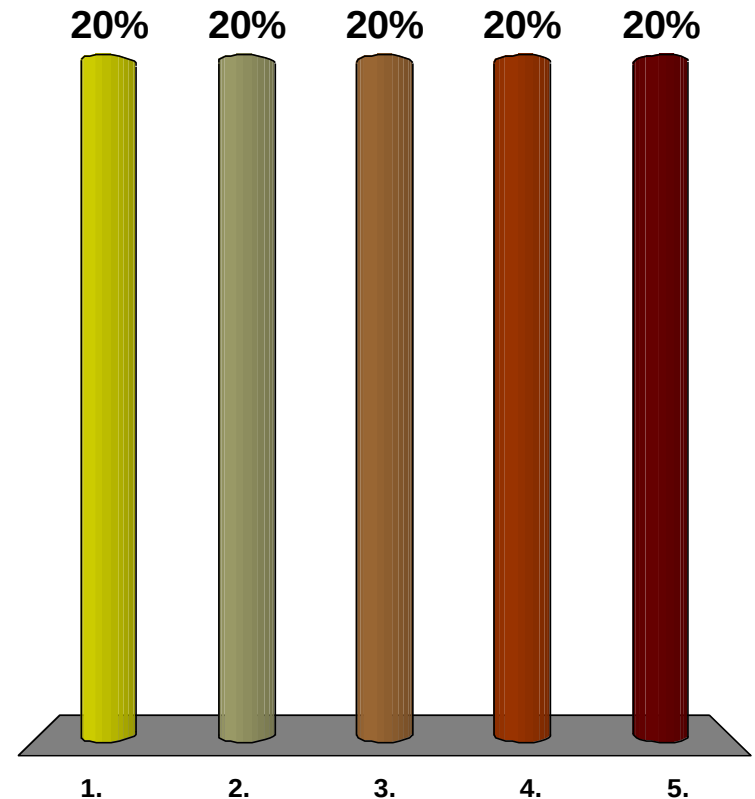
Conjonctivite

1. Bactérienne à *Hemophilus influenzae*
2. Allergique
3. Virale à adénovirus
4. A *Neisseria gonorrhoei*
5. Sur kératite amibienne à *Acanthamoeba*



Le diagnostique le plus probable est une
conjonctivite :

1. Bactérienne à *Hemophilus influenzae*
2. Allergique
3. Virale à adénovirus
4. A *Neisseria gonorrhoei*
5. Sur kératite amibienne à *Acanthamoeba*



Conjonctivite virale à adénovirus

Conjonctivites: inflammations de la conjonctive

Type:

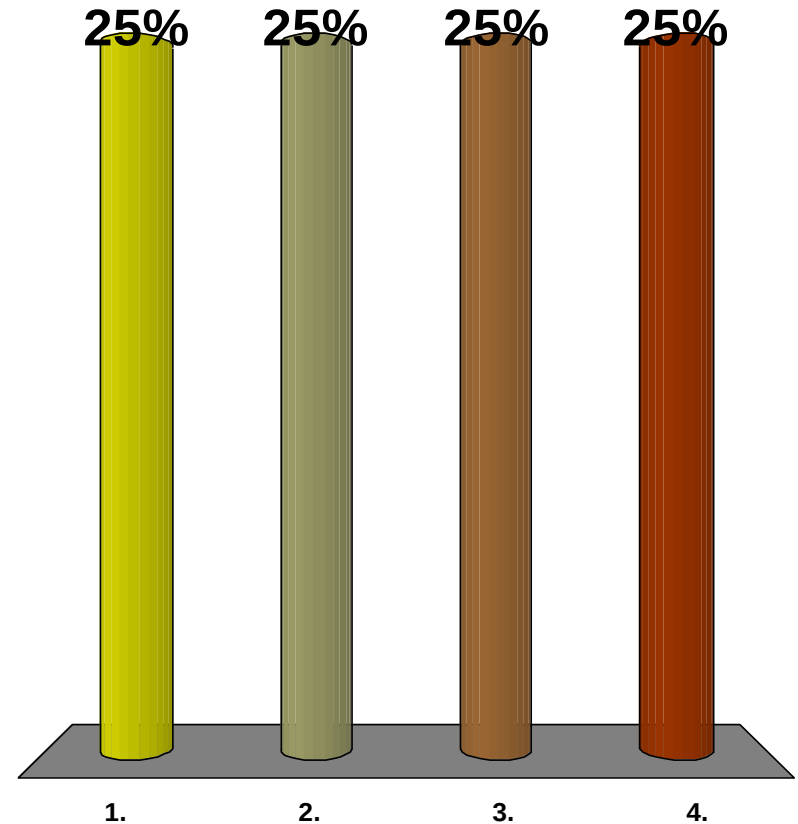
- ❑ **Virale :** (adénovirus), très contagieux, oeil très rouge, enflé (chémosis), larmoyant, sécrétions séreuses initialement. Transmission terriblement contagieuse, la transmission étant manu portée. Isolement du patient arrêt de travail 2 semaines si risque de contacts. Aspect folliculaire de la conjonctive à la lampe à fente.
- ❑ **Allergique:** Prurit important, sécrétions muco-purulentes, rougeur chronique. Dans les formes saisonnières augmentation de la rougeur lors de la période d'allergie. Forme particulière allergie poussière de maison et rhume des foins. Aspect papillaire de la conjonctive à la lampe à fente.
- ❑ **Bactérienne:** écoulement purulent, l'oeil est collé, sécrétions abondantes. Forme particulière de conjonctivite bactérienne: conjonctivite gonococcique = conjonctivite suraiguë, risque de perforation oculaire en moins de 24 heures si non diagnostiquée
- ❑ **Conjonctivite à Chlamydia:** Transmise sexuellement ou par contact indirect. Conjonctivite folliculaire (follicules lymphatiques).
- ❑ Si la cornée est touchée penser également à la kératite **amibienne** (forme gravissime d'atteinte de la cornée chez les porteurs de lentille de contact causée par des amibes). "Kératite à Acanthamoeba".

En tant qu'ophtalmo-pédiatre, vous diagnostiquez une cataracte nucléaire bilatérale chez un enfant de 12 mois, dont le fond d'œil est mal éclairable mais sans lésion visible, qui vous est référé par le pédiatre en raison d'un nystagmus récent. Quelle est votre attitude?

1. Préconiser une période d'observation à toutes fins utiles
2. Rechercher un vice de réfraction et le corriger
3. Compléter le bilan avec une IRM cérébrale afin d'exclure une pathologie du système nerveux central
4. Poser l'indication à une lentectomie bilatérale en raison de la nature amblyogène de la cataracte

Quelle est votre attitude?

1. Période d'observation
2. Rechercher un vice de réfraction et le corriger
3. IRM cérébrale
4. Lentectomie bilatérale



Poser l'indication à une lentectomie bilatérale
en raison de la nature amblyogène de la
cataracte

En présence d'une cataracte
nystagmogène rapidement évolutive
(apparition récente du nystagmus),
une prise en charge chirurgicale
diligente est nécessaire afin de ne
pas assombrir le pronostic visuel